

Gestão de Serviços de Farmácia

**Flávia Deffert
Felipe Mateus Deffert**



Aula 02



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDUARDO NASCIMENTO DE ARRUDA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

Os Autores

FLÁVIA DEFFERT

FELIPE MATEUS DEFFERT

Olá. Para a escrita dessa unidade letiva, eu Flávia Deffert e Felipe Mateus Deffert, meu irmão unimos nossas forças para a escrita desse material todo especial para você. Eu sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Paraná onde, também, cursei mestrado em Ciências Farmacêuticas. Após o mestrado, pude experienciar atividades administrativas e à docência. Como experiência profissional, trabalhei em duas fundações nas quais fui a responsável pelo setor de compras – licitações e fui farmacêutica da diretoria técnica da sede de uma gestora de hospitais públicos estaduais. Na última realizei atividades relacionadas a seleção, programação e aquisição de produtos para saúde, insumos e medicamentos. O Felipe é formado em Direito pela PUC/PR e cursou pós-graduações em Direito Público pela Escola de Magistratura Federal do Estado do Paraná e cursa pós-graduação em Direito Notarial e Registral e em Direito Imobiliário na Universidade de Lisboa, Portugal. Estuda (e passa) em concursos públicos e atua como advogado autônomo, vindo para somar na nossa trajetória pela legislação. Amamos o que fazemos e queremos transmitir o que nosso conhecimento e experiências com você, que está iniciando a sua profissão. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estamos muito felizes em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Iconográficos

Olá. Meu nome é **Manuela César de Arruda**. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conhecendo a legislação aplicada aos serviços de farmácia.....	10
Fundamentos do direito.....	10
Lei 8080/90 e a regulamentação do SUS.....	15
Regulamentações sobre a profissão farmacêutica.....	20
Fiscalização das atividades farmacêuticas.....	22
Conhecendo os padrões mínimos de estrutura física, equipamento e recursos humanos.....	27
Padrões mínimos de estrutura física para os serviços farmacêuticos.....	28
Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF).....	31
Área de dispensação.....	32
Área de manipulação.....	32
Centro de Informações de Medicamentos (CIM).....	32
Farmácia Satélite.....	33
Área administrativa.....	33
Parâmetros mínimos de equipamentos e utensílios.....	34
Parâmetros Mínimos de recursos humanos.....	34
Explorando os princípios da administração.....	37
Histórico dos princípios da administração.....	38
Gestão e a Política Nacional de Medicamentos e da Assistência Farmacêutica.....	48
Política Nacional de Medicamentos e OMS.....	48
RENAME.....	49
Regulamentação sanitária.....	50
Reorientação da assistência farmacêutica.....	51

UNIDADE

02

INTRODUÇÃO

Olá pessoal! A farmácia hospitalar, do mesmo modo que toda e qualquer atividade profissional, segue princípios legais determinados pela Constituição Federal, Leis Federais, Estaduais e Municipais, Decretos e Resoluções. O não cumprimento dessas normas pode levar a suspensões, multas e, até mesmo, prisões. Além disso, como a infraestrutura também é determinada por resoluções da ANVISA, a falta de concordância pode causar até a suspensão do funcionamento do serviço de saúde. Imagine só!!! Melhor aprendermos certinho todas elas, não é? E, aí? Prontos? Vamos lá! Não se esqueça que todas essas leis e normas são orgânicas, sendo alteradas de tempos em tempos... então, atualize-se!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Conhecer a legislação aplicada aos serviços farmacêuticos;
2. Conhecer os padrões mínimos para a estrutura física, equipamentos e recursos humanos para serviços de farmácia;
3. Explorar os princípios da administração;
4. Conectar os princípios de gestão à Política Nacional de Medicamentos e da Assistência Farmacêutica.

Não se esqueça do que o nosso nobre autor Guimarães Rosa certa vez mencionou: O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Conhecendo a legislação aplicada aos serviços de farmácia



INTRODUÇÃO:

Ao término dessa competência você aprenderá sobre os fundamentos jurídicos dos serviços farmacêuticos. Da mesma forma que outras profissões, regulamentações existem para o bom decorrer das atividades e garantir a qualidade do atendimento ao paciente. Faz parte do seu trabalho como gestor de serviços de farmácia conhecer qual os limites legais para o seu trabalho. Entendeu? Vamos nessa?!

Fundamentos do direito

Os serviços farmacêuticos são, da mesma forma que muitos outros, regulados por meio de legislações específicas. Essas, por sua vez, são subdivididas dependendo de onde esses serviços são realizados, por exemplo: farmácia comunitária, farmácia magistral, indústria ou farmácia hospitalar. Sobre o assunto o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, em um guia sobre a profissão farmacêutica apresenta:

"O Brasil criou seu primeiro curso de Farmácia em 1832, no Rio de Janeiro. Até então, o boticário era o profissional autorizado a exercer as funções correspondentes às do atual farmacêutico. Em 1931, a profissão foi finalmente regulada, passando a ser exercida apenas por farmacêutico diplomado em instituições de ensino oficialmente reconhecidas." (CRF/PR, 2015).

Como o intuito do nosso material é abordar os serviços farmacêuticos em farmácia hospitalar, iremos, em primeiro lugar, abordar legislações da profissão e do serviço farmacêutico, em seguida falaremos da legislação específica.

Também, é importante informar que as leis, decretos, normas, etc., estão sob constante atualização e, no nosso caso, podem ser emitidas por diferentes órgãos: Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde, Conselhos de Classe: Conselho Federal da Farmácia e Conselho Regional de Farmácia entre outros, através de publicações em Diários Oficiais da União, Estados e Municípios. Ainda, a vigência dessas leis deve seguir uma determinada hierarquia que segue do topo a base de uma pirâmide denominada de pirâmide de Kelsen.

Figura 1: Representação esquemática da pirâmide de Kelsen



Fonte: Wikimedia commons

Essa ordenação também deve ser respeitada em termos dos Governos Federal, Estaduais e Municipais e demais órgãos que constituam a administração direta e indireta.

Leis gerais aplicadas a saúde

A Constituição é a "lei fundamental" do Estado. Todas as normas do ordenamento jurídico devem ser compatíveis com a Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas.

Dos seus artigos 1º ao 4º encontram-se os princípios fundamentais que devem reger e fundamentar todos os demais artigos e qualquer forma de legislação. Nesses artigos ganham destaque pelo interesse à saúde o inciso III do artigo 1º:

"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III – a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA;" (BRASIL, 1988)

O que isso significa? Significa que qualquer ser humano tem direito de ser concebido e nascer, viver, e, morrer de forma digna. Aos olhos da doutrina constitucional, vida é um processo que se inicia com a concepção e passa pela transformação ou evolução, mantendo a identidade da pessoa humana, finalizando com a sua morte.

Esse inciso também vai de encontro ao conceito da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Importante destacar que esse conceito holístico da OMS estipulado em 1947 abrange a responsabilidade da saúde não a um somente ministério ou secretaria, mas, sim, a todas. Ou seja, abrange aspectos de saúde, infraestrutura e cultura, por exemplo.

De volta à CF 1988, o artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos e o 6º dos direitos sociais. Nesses artigos ganham destaque:

Art. 5º, caput:

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à VIDA, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"

O artigo 5º caput promove a compreensão de que qualquer pessoa em território nacional deve ser tratada igualmente e que todas apresentam os mesmos direitos.

Já, o art. 6º, caput, demonstra o caráter social da CF 1988, de modo a listar os direitos que representam o mínimo para que os presentes em território nacional estejam em um estado de bem-estar quando supridos:

"São direitos sociais a educação, a SAÚDE, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Esses direitos estão presentes em cláusulas denominadas de pétreas, isto é, só poderão ser alteradas por meio de nova assembleia constituinte.



REFLITA:

O artigo 5º garante a qualquer vida humana desde a sua concepção o direito inviolável a vida. Nesse contexto, pense sobre as questões de SAÚDE que possam levar a morte da mãe ou do bebê e da necessidade de um aborto. Quando pode-se justificar o aborto na atualidade à luz da doutrina vigente?

O título da oitava parte da carta régia diz respeito a ordem social que tem como base o trabalho e objetivos o bem-estar e justiça social. Nesse título, a seção II trata da saúde e no artigo 196 há a redação de um dos mais conhecidos artigos pelos profissionais de saúde:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Nessa seção os artigos 197 e 198 traçam as primeiras linhas do Sistema Único de Saúde:

"Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado."

O artigo 198 apresenta as diretrizes organizativas do sistema único de saúde.

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (...)”

A garantia da participação da iniciativa privada é feita por meio do art. 199. A participação será complementar ao do atendimento público, sendo preferencial a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

"Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos."

O artigo 200, por sua vez, trata das atribuições do SUS, dentre as quais estão:

I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

- II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- IV - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- V - Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;
- VI - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
- VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho

Lei 8080/90 e a regulamentação do SUS

A partir da CF 1988, foi publicada a lei n 8080, de 19 de setembro de 1990, que "(...) regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado." – artigo 1, caput.

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Ainda, no artigo 3º há uma consonância do conceito de saúde holístico com o praticado pela Organização Mundial da Saúde:

"Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social".

Lembrou? É o conceito de saúde pela OMS. Preste atenção!

Sistema Único de Saúde é conceituado como "conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)." (art. 4º). Os objetivos do Sistema Único de Saúde são:

"Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas".

Os princípios e diretrizes do sistema único de saúde estão dispostos no capítulo segundo:

"Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - Qualidade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - Participação da comunidade;

IX - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV - Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013".

As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Dessa forma, cabe aos municípios a atenção básica, de menor complexidade, passando aos estados e ao governo federal os atendimentos de maior complexidade. Outras leis de importância para a prática de serviços farmacêuticos são:

- Decreto nº 20.377, de 8 de setembro de 1931: Aprova a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil

- Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960: cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras Providências.

- Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973: dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;

- Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976: dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos;

- Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014: dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.

- Portaria nº 1.565/MS/GM, de 26 de agosto de 1994: Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua abrangência, esclarece a competência das três esferas de governo e estabelece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

- Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960: cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras Providências.

- Decreto nº 85.878 de 7 de abril de 1981: Estabelece normas para execução de Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, sobre o exercício da profissão de farmacêutico, e dá outras providências.

- Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998: Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

- Portaria nº 1.017 de 23 de dezembro de 2002: estabelece que as Farmácias Hospitalares e/ou dispensários de medicamentos existentes nos Hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde deverão funcionar, obrigatoriamente, sob a Responsabilidade Técnica de Profissional Farmacêutico devidamente inscrito no respectivo Conselho Regional de Farmácia (artigo 1):

- RDC 67, de 8 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em farmácias (incluindo as hospitalares).



IMPORTANTE:

Atenção!! As legislações em vigor para qualquer outro tipo de serviço farmacêutico devem ser cumpridas no ambiente da farmácia hospitalar sempre que não houver legislação própria. Isso é muito importante!



ACESSE:

Para facilitar aos profissionais, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná elaborou um guia que já está na quinta edição denominado de "Requisitos legais e regulamentares da farmácia hospitalar" que apresenta um compilado de leis e normas importantes para a execução dos trabalhos. Esse guia é periodicamente revisado e republicado no site do CRF/PR. <http://bit.ly/2TgmBvH>

Regulamentações sobre a profissão farmacêutica

A partir do decreto nº 20377, de 8 de setembro de 1931, houve a regulamentação da profissão farmacêutica em território nacional a qual só pode ser exercida por profissional de ensino superior em curso específico de farmácia.

Mais tarde, em 1981, foi publicado pelo governo federal o decreto de número 85878, que dispõe sobre a profissão farmacêutica e atualiza o de 31 e regulamenta a lei 3820, de 11 de novembro de 1960. Nesse decreto estabelece-se as atribuições privativas ou não do farmacêutico.

"Art. 1º São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos:

I - Desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada;

a) estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabriquem produtos que tenham indicações e/ou ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou capazes de criar dependência física ou psíquica;

b) órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos ou capazes de determinar dependência física ou psíquica;

c) órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral;

d) depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza;

III - a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas,

estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;

IV - A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;

V - O magistério superior das matérias privativas constantes do currículo próprio do curso de formação farmacêutica, obedecida a legislação do ensino;

VI - Desempenho de outros serviços e funções, não especificados no presente Decreto, que se situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional."

No artigo segundo, por sua vez, lista-se diversas atribuições do farmacêutico que não são específicas. Tais como:

I - A direção, o assessoramento, a responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em:

a) estabelecimentos em que se preparem ou fabriquem produtos imunobiológicos e imunoterápicos;

b) órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados;

c) estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário;

e) estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e desinfetantes;

g) estabelecimentos industriais, instituições governamentais ou laboratórios especializados em que se fabriquem conjuntos de reativos ou de reagentes destinados às diferentes análises auxiliares do diagnóstico médico;

II - Tratamento e controle de qualidade das águas de consumo humano;

A resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 160, de 23 de abril de 1982, que dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica complementa o exposto no decreto de 1981.

“Art. 1º - O título de farmacêutico, em qualquer de suas modalidades, para todos os efeitos de direito, é exclusivo do profissional de nível superior, graduado em estabelecimento de ensino de ciências farmacêuticas. (...)”.

Fiscalização das atividades farmacêuticas

A lei n. 13021, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Essa lei é aplicável a todos os ambientes onde pode-se prestar serviços farmacêuticos e apresenta no seu artigo primeiro algumas definições importantes para a compreensão de todo o nosso trabalho.

“Art. 2º Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos”.

Para o funcionamento de uma farmácia de qualquer natureza se exige a autorização e o licenciamento da autoridade competente, além de possuir a presença do farmacêutico durante o período de funcionamento,

ser adequadamente localizada sob aspecto sanitário e dispor dos medicamentos necessários. Além disso, deve dispor de recursos materiais que garantam a conservação e qualidade dos medicamentos e imunobiológicos, como também a segurança dos trabalhadores.

As obrigações do profissional farmacêutico no exercício de suas atividades são estabelecidas no artigo 13 °:

“Art. 13. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a:

I - Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância;

II - Organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia;

III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada;

IV - Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica;

V - Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas;

VI - Prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.”

Ainda, fica estabelecido que a farmácia hospitalar ou similar a essa se destina exclusivamente ao atendimento de seus usuários. Segundo o CRF/PR, a farmácia hospitalar é responsável por todo o ciclo do medicamento, desde sua seleção (ativos e fornecedores), armazenamento, controles, até a dispensa e o uso pelo paciente.

"A atuação do farmacêutico hospitalar é muito abrangente. Ele é responsável pela orientação aos pacientes internos e ambulatoriais, buscando cooperar na efetividade do tratamento e redução dos custos. O farmacêutico, diretor técnico da farmácia de hospital deve cumprir e fazer cumprir todas as regras profissionais e sanitárias em relação às atividades de hospital: organizar, supervisionar, acompanhar e orientar todos os setores que compõem os serviços da farmácia hospitalar fazendo com que o produto ou serviço oriundo da farmácia tenha qualidade assegurada para o cuidado do paciente." (CRF/PR, 2015).

Para complementar as demais leis, decretos e normas, o Conselho Federal de Farmácia por meio da resolução 585, de 29 de agosto de 2013, regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. De modo sintético as atividades clínicas do farmacêutico visam proporcionar cuidado ao paciente, família e comunidade, de forma a promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente.

As atribuições clínicas estão descritas na resolução do CFF supracitada e apresenta 28 incisos esclarecedores sobre esses serviços farmacêuticos.

"Art. 7º - São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo:

I – Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente;

II - Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;

III - Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que ele tenha condições de realizar o tratamento e alcançar os objetivos terapêuticos;

IV - Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos;

V - Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente;

VI - Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde;

VII - Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento;

VIII - Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o propósito de prover cuidado ao paciente;

IX - Acessar e conhecer as informações constantes no prontuário do paciente;

X - Organizar, interpretar e, se necessário, resumir os dados do paciente, a fim de proceder à avaliação farmacêutica;

XI - Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia;

XII - Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento para individualização da farmacoterapia;

XIII - Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio de dados de farmacocinética clínica;

XIV - Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em saúde;

XV - Prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia;

XVI - Identificar, avaliar e intervir nas interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes;

XVII - Elaborar o plano de cuidado farmacêutico do paciente;

XVIII - Pactuar com o paciente e, se necessário, com outros profissionais da saúde, as ações de seu plano de cuidado;

XIX - Realizar e registrar as intervenções farmacêuticas junto ao paciente, família, cuidadores e sociedade;

XX - Avaliar, periodicamente, os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas, construindo indicadores de qualidade dos serviços clínicos prestados;

XXI - Realizar, no âmbito de sua competência profissional, administração de medicamentos ao paciente;

XXII - Orientar e auxiliar pacientes, cuidadores e equipe de saúde quanto à administração de formas farmacêuticas, fazendo o registro destas ações, quando couber;

XXIII - Fazer a evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente;

XXIV - Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos em uso pelo paciente durante os processos de admissão, transferência e alta entre os serviços e níveis de atenção à saúde;

XXV - Dar suporte ao paciente, aos cuidadores, à família e à comunidade com vistas ao processo de autocuidado, incluindo o manejo de problemas de saúde autolimitados;

XXVI - Prescrever, conforme legislação específica, no âmbito de sua competência profissional;

XXVII - Avaliar e acompanhar a adesão dos pacientes ao tratamento, e realizar ações para a sua promoção;

XXVIII - Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnico-científicas e em consonância com as políticas de saúde vigentes."

A farmácia clínica vem colaborar com uma equipe multidisciplinar. Mais facilmente adotada em hospitais, os farmacêuticos clínicos têm a aptidão para colaborar com os outros profissionais de saúde a fim de obter a cura ou a melhora da qualidade de vida do paciente.

Agora é hora da revisão! Nessa competência vimos o histórico da legislação relativa ao surgimento do Sistema Único de Saúde, da regulamentação do sistema único de saúde e da profissão farmacêutica e sua fiscalização. Vimos que o surgimento do SUS iniciou-se na CF de 1988 e foi regulamentado pela lei 8080/90. Vimos que a regulamentação da profissão farmacêutica no Brasil se deu durante o governo de Getúlio Vargas e, mais tarde atualizada, já na década de 80. Conhecemos também as atribuições do farmacêutico clínico, que eram, até recentemente, menosprezadas. Viu quantas coisas podem compor o leque de serviços farmacêuticos?

Conhecendo os padrões mínimos de estrutura física, equipamento e recursos humanos



INTRODUÇÃO:

Nessa competência iremos conhecer os padrões mínimos para a infraestrutura, isto é, espaço físico e equipamentos, além da sugestão do número de colaboradores para compor os recursos humanos desse setor. Esse conhecimento é importante para que você sabia como planejar esse espaço, que influencia (e isso você precisa ter em mente) na liberação de um alvará sanitário. Além disso, o número de pessoal em quantidade suficiente e infraestrutura adequada facilitam o serviço, diminuindo movimentos desnecessário e doenças ocupacionais. Ou seja, influencia diretamente no desempenho do trabalhador e na eficiência do processo.

Padrões mínimos de estrutura física para os serviços farmacêuticos

As estruturas físicas de estabelecimentos de serviços de saúde são regulamentadas pela RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 que trata da aprovação de um regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimento assistenciais de saúde. A farmácia para essa resolução define-se como unidade destinada a programar, receber, estocar, preparar, controlar e distribuir medicamentos ou afins e/ou manipular fórmulas magistrais e oficinais.

Segundo a RDC 50, a farmácia como um serviço de apoio técnico aos estabelecimentos de saúde apresenta como atividades:

"5.2-Proporcionar assistência farmacêutica:

5.2.1-Receber e inspecionar produtos farmacêuticos;

5.2.2-Armazenar e controlar produtos farmacêuticos;

5.2.3-Distribuir produtos farmacêuticos;

5.2.4-Dispensar medicamentos;

5.2.5-Manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;

5.2.6-Preparar e conservar misturas endovenosas (medicamentos)

5.2.7-Preparar nutrições parenterais;

5.2.8-Diluir quimioterápicos;

5.2.9-Diluir germicidas;

5.2.10-realizar controle de qualidade; e

5.2.11-prestar informações sobre produtos farmacêuticos."

Essa resolução também estabelece as áreas mínimas para a execução das atividades, conforme tabela extraída da resolução.

Tabela 1. Áreas e instalações recomendadas como padrões mínimos para uma farmácia que preste assistência a serviço de saúde

Farmácia			
UNIDADE / AMBIENTE	DIMENSIONAMENTO		INSTALAÇÕES
	QUANTIFICAÇÃO (min.)	DIMENSÃO (min.)	
Área para recepção e inspeção – ativ. 5.2.1	1	10 % da área para armazenagem	
Área para armazenagem e controle (CAF) ¹ - Matéria prima: - Inflamáveis - Não inflamáveis - Material de embalagem e envase - Quarentena - Medicamentos - Termolábeis (23° à 25° no máximo) - Imunobiológicos (4°C à 8°C e - 18°C à - 20°C) - Controlados - Outros - Materiais e artigos médicos descartáveis - Germicidas - Soluções parenterais - Correlatos - ativ. 5.2.2	1 (de cada). A depender das atividades do estabelecimento.	-0,6 m por leito -Termolábeis = a depender da temperatura e umidade da região e do tipo de embalagem dos medicamentos. -Imunob.= 2,0 m p/ freezer ou geladeira. A depender do equipamento, no caso do uso de câmaras fria.	E; ADE EE (área de imuno- biológicos)
Área de distribuição – ativ. 5.2.3	1	10 % da área para armazenagem	
Área para dispensação (farmácia satélite) – ativ. 5.2.4		4,0 m. Pode ser substituída por carrinhos de medicamentos ou armários específicos.	HF
Farmacotécnica - - ativ. 5.2	A existência dessa sub- unidade dependerá da execução ou não das atividades correspondentes		
Sala de manipulação, fracio. de doses e reconstituição de medicamento – ativ. 5.2.5	1	12,0 m	HF; ADE
Área de dispensação – ativ. 5.2.4	1	6,0 m	HF
Sala para preparo e diluição de germicidas – ativ. 5.2.9	1	9,0 m	HF; E
Laboratório de controle de qualidade – ativ. 5.2.10	"In loco" ou não	6,0 m	HF; FG; ED; ADE
Centro de informação sobre medicamento – ativ. 5.2.11		6,0 m	
Sala de limpeza e higienização de insumos (aspepsia de embalagens) ^{2 3} - ativ. 5.2.7 e 5.2.8	1	4,5 m	HF; AC
Sala de preparação de quimioterápicos ³ - ativ. 5.2.8	1	5,0 m por capela de fluxo laminar	AC; ED
Sala de manipulação de nutrição parenteral 4 – ativ. 5.2.7	1	5,0 m por capela de fluxo laminar	AC

Notas:

- Vide Portaria MS nº 3.535 de 02/09/98 e Portaria MS 255 de 31/03/99 sobre centros de atendimento de oncologia, publicadas no DO de 14/10/98 e 01/04/99 e na Portaria MS/SAS nº 113 de 31/03/99 sobre cadastramento de serviços, publicada no DO de 08/04/99.

- Ambientes de apoio: sanitários para funcionários; depósito de material de limpeza, farmacotécnica, sanitários com vestiários para funcionários, sala administrativa, vestiário (barreira as sala de limpeza e higienização e salas de manipulação) ³, depósito de material de limpeza, sala de esterilização de materiais, *copa.

- ¹ Vide Manual de Recomendações para Projetos de Construção de Almoxxarifados Centrais de Medicamentos, CEME - Central de Medicamentos, 1984 e Guia Básico de Farmácia Hospitalar, Min. Da Saúde, 1994.

- ² optativo quando não houver preparação de quimioterápicos ou manipulação de nutrição parenteral. Uma única sala pode servir a sala de quimioterápicos e a sala de nutrição parenteral.

- ³ estas salas podem estar localizadas na unidade de quimioterapia ou na farmácia, sempre sob a responsabilidade de um farmacêutico. Deve possuir visor que possibilite a visão da capela de fluxo laminar.

- 4 Vide Portaria nº 272 de 08/04/98 do Ministério da Saúde publicada no DO de 23/04/98
Legendas: HF- Água fria; FG - Gás combustível; AC - Ar condicionado (1); CD - Coleta e afastamento de efluentes diferenciados (2); EE - Elétrica de emergência (3); ED - Elétrica diferenciada (4); E - Exaustão (5); ADE - A depender dos equipamentos utilizados. Nesse caso é obrigatória a apresentação do "lay-out" da sala com o equipamento.

(1) Refere-se à climatização destinada à ambientes que requerem controle na qualidade do ar.

(2) Refere-se à coleta e afastamento de efluentes que necessitam de algum tratamento especial.

(3) Refere-se à necessidade de o ambiente ser provido de sistema elétrico de emergência.

(4) Refere-se à necessidade de o ambiente ser provido de sistema elétrico diferenciado dos demais, na dependência do equipamento instalado. Exemplo: sistema com tensão diferenciada, aterramento etc.

(5) É dispensável quando existir sistema de ar recirculado.

(6) Canalizado ou portátil.

Fonte: Brasil, 2002

Sobre o assunto, outros autores descrevem que a área física da farmácia hospitalar também deve ser dimensionada de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento de saúde em que está alocado e, também, pela complexidade do cuidado prestado. A OPAS recomenda que a área física da farmácia seja de 1,2 m² por leito.

Nem todas as farmácias precisarão desenvolver todas as atividades, irá depender, dentre outras coisas do tipo de pacientes a serem atendidos, a infraestrutura e do orçamento disponível para investimento. Algumas delas podem ser terceirizadas, ficando desobrigadas de apresentar a área destinada à atividade que será realizada em outro local/empresa. Isso é muito comum quando não há local específico para a realização de atividades de manipulação de medicamentos, quimioterápicos e outros medicamentos injetáveis que necessitam de local adequado para sua manipulação e garantia da qualidade.

"As manipulações enterais e parenterais e as manipulações quimioterápicas são muitas vezes terceirizadas, em razão da complexidade de produção, da necessidade de ambientes estéreis e do alto custo dos equipamentos, como as capelas de fluxo laminar." (JULIANI, 2018, p. 24)

Além disso, deve apresentar área suficiente para o estoque de medicamentos necessários para um determinado período, esse, por sua vez, é influenciado pela quantidade de pessoas atendidas, localização e facilidade de acesso, bem como, a política de compras da instituição.

Para obter um funcionamento satisfatório, a unidade de farmácia hospitalar deve contar, no mínimo, com os seguintes ambientes: área para administração; área para armazenamento; área de dispensação e orientação farmacêutica.

Outras áreas específicas para cada atividade a ser desenvolvida, sendo que algumas já foram citadas na tabela transcrita da RDC 50/2002. Vamos detalhar um pouco mais cada uma delas?

Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

É a unidade de assistência farmacêutica onde é feita a estocagem dos materiais (medicamentos, correlatos, insumos, entre outros). Na CAF são realizadas as atividades de recepção, armazenamento e distribuição dos materiais.

O seu objetivo é garantir a correta conservação dos medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais, dentro dos padrões e normas técnicas específicas, para assegurar a manutenção das características e qualidade necessárias à sua correta utilização.

Os medicamentos e demais produtos utilizados devem ser armazenados de forma adequada, separadas de acordo com suas características e específicas. Além disso, da necessidade de estabelecer uma área de quarentena para certificar-se da qualidade dos produtos recebidos.

A CAF deve estar localizada em área de fácil acesso interno e externo, com área de circulação adequada as atividades, facilitando o recebimento e a distribuição dos produtos. Além de contar com equipamentos adequados para a segurança dos trabalhadores e contra incêndios e demais acidentes ocupacionais.

Área de dispensação

Ela deve estar próxima ao CAF por conveniência e são recomendados locais específicos para a recepção, supervisão farmacêutica, separação de medicamentos, estocagem para uso a curto prazo, para medicamentos mantidos sob refrigeração e a área para medicamentos sujeitos a controle especial.

Em alguns casos, conta-se com uma farmácia ambulatorial, quando o hospital é referência no atendimento especializado como para hepatite B ou C, HIV, entre outros. O atendimento pode ser realizado em salas, desde que seja garantida a privacidade dos pacientes. É recomendável que haja uma recepção ou antessala, onde sejam dispostas cadeiras para que os pacientes esperem seu atendimento confortavelmente.

Área de manipulação

Na área de manipulação podem ser realizadas as atividades de manipulação de fórmulas enterais e parenterais, além da linearização e fracionamento de doses e adaptações de formas farmacêuticas.

“Para realizar atividades de manipulação, a farmácia deve dispor de áreas para as atividades administrativas, de armazenamento, controle de qualidade e dispensação além de salas exclusivas para a pesagem e a manipulação propriamente dita.

A farmacotécnica desenvolvida nos hospitais visa, principalmente, a atender as necessidades das clínicas infantis, elaborando medicamentos em apresentações de administração mais fácil, como soluções e xaropes. Outros pacientes como idosos e com a deglutição dificultosa também se beneficiam da alteração da forma farmacêutica.

A farmacotécnica também visa a linearização e individualização das doses.

Centro de Informações de Medicamentos (CIM)

O CIM objetiva fornecer informações sobre medicamentos para as equipes de saúde. Sendo assim, é importante ter acesso a bancos de dados atualizados, livro e artigos científicos atuais. É função da farmácia

hospitalar disseminar as informações sobre os medicamentos, suas ações, interações, efeitos colaterais, efeitos adversos, principais usos, promovendo o uso racional. Para isso deve elaborar e divulgar boletins informativos sobre seu uso.

Farmácia Satélite

A Farmácia Satélite pode ser uma alternativa para evitar os deslocamentos longos e para agilizar a entrega dos medicamentos aos setores hospitalares, otimizando o sistema de distribuição de medicamentos. Geralmente localizam-se na unidade de emergência, unidade cirúrgica, unidade de tratamento intensivo, entre outros locais que cada segundo pode fazer a diferença para salvar uma vida. Nesses locais há um pequeno estoque de materiais para facilitar o acesso aos profissionais de saúde.

Área administrativa

A área administrativa é a responsável pela organização e suporte aos processos de trabalho da farmácia, abrangendo manutenção, controle patrimonial e apoio logístico. Por meio desse setor articulam-se ações para compras, controle de estoque, estudos de consumo e custos, previsão das atividades e relacionamento com os outros setores do hospital.

Além das áreas citadas, a SBRAFH recomenda que a gerência da farmácia conte com ambiente privativo, suporte administrativo e que haja recursos para as atividades de informação sobre medicamentos e produtos para saúde e de farmacovigilância.

A localização da farmácia hospitalar, para a SBRAFH, deve estar localizada em ponto estratégico, que facilite a provisão de serviços a pacientes, a distribuição de medicamentos e o armazenamento dentro dos critérios técnicos, devendo contar com recursos de comunicação e transporte e boas condições ambientais.

Parâmetros mínimos de equipamentos e utensílios

A Sociedade também sugere que equipamentos e utensílios deverão seguir as normas do INMETRO, ficando evidenciada as suas: aferição, calibração e certificações, quando aplicável. Sendo que para a SBRAFH o parâmetro mínimo para equipamentos e utensílios são:

- Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva: Cabines de segurança biológica, fluxo laminar, máscaras, gorros, aventais, capotes, óculos de proteção e luvas;

- Medição: Termômetros de transporte, Termômetro de refrigeradores e de Ambientes, Termo higrômetros, Balanças, PHmetro;

- Conforto ambiental: Condicionadores de ar com manutenção preventiva e corretiva, mantendo a temperatura ambiente abaixo dos 25°C;

- Guarda e acondicionamento de produtos: Refrigeradores, freezers, câmaras de vacina e câmaras frias, pallets, estantes, armários, caixas térmicas, caixas plásticas, bins, gelo de transporte, caixa plástica com tranca para guarda de produtos sujeitos a controle especial (UTIs, Pronto Atendimento e Bloco Cirúrgico) e bandejas;

- Unitarização, fracionamento e montagem de kits Seladora plástica, encapsuladoras, envasadoras;

- Informática Computadores, leitores de código uni e bidimensionais, impressoras, rotuladoras;

- Transporte Carrinho tipo bandeja, carinho tipo plataforma;

- Outros utensílios e insumos: Vidrarias, bandejas, bobinas plásticas, etiquetas, fitas, dentre outros necessários ao serviço.

Parâmetros Mínimos de recursos humanos

A SBRAFH aconselhou parâmetros mínimos de funcionários para estabelecer um bom serviço farmacêutico. O número correto de colaboradores, desde que bem geridos, diminuem o acúmulo de tarefas e aumentam a satisfação de realizar aquele trabalho.

Além disso, segundo o Artigo 6º da Lei 13.021/2014, farmácias de qualquer natureza necessitam ter farmacêutico em todo o horário de funcionamento a fim de obter autorização e licenciamento para o seu pleno funcionamento.

O Artigo 8º e seu parágrafo único, da mesma lei, ressalta ainda que as farmácias privativas de hospitais e estabelecimentos de saúde similares, destinam-se a atender exclusivamente seus usuários, estando igualmente sujeitas às mesmas exigências legais previstas para as farmácias não privativas, no que concerne à direção e desempenho técnico dos farmacêuticos, bem como ao registro no Conselho Regional de Farmácia.

A tabela mostra a alocação dos recursos humanos para determinadas atividades. Importante lembrar que nem sempre o estabelecimento de saúde terá todas essas atividades.

Tabela 2. Padrões mínimos de recursos humanos

Padrões Mínimos de Recursos Humanos	
Atividades	Recursos Humanos
Atividades básicas de dispensação para pacientes internados	1 farmacêutico para cada turno/plantão diurno 1 farmacêutico para cada turno/plantão noturno 1 auxiliar de farmácia para cada turno/ plantão diurno 1 auxiliar administrativo para cada turno/ plantão diurno
Central de Abastecimento Farmacêutico e Logística de Suprimentos	1 farmacêutico em horário administrativo 1 almoxarife
Assistência em Terapia Nutricional Parenteral	1 farmacêutico para cada 20 pacientes 1 auxiliar de farmácia para cada 20 preparações de NPT
Manipulação de Antineoplásicos	1 farmacêutico para cada 50 preparações de quimioterapia 1 auxiliar de farmácia para cada 100 preparações de quimioterapia
Manipulação de outras misturas intravenosas	1 farmacêutico por turno 1 auxiliar de farmácia por turno
Manipulação de medicamentos não estéreis, fracionamento e unitarização	1 farmacêutico por turno durante as operações de manipulação 1 auxiliar de farmácia de farmácia por turno
Farmácia Ambulatorial (gerenciamento e controle de estoque)	1 farmacêutico por turno de atendimento 1 auxiliar administrativo 1 auxiliar de farmácia para cada 100 pacientes/dia
Orientação farmacêutica	1 farmacêutico (dispensação orientada) para cada 100 pacientes/dia (média de 5 minutos para orientação de cada paciente)
Programas de Seguimento Farmacêutico	1 farmacêutico por consultório do Programa de Atenção Farmacêutica (2 consultas/hora, primeira consulta com 1 hora de atendimento)

Assistência domiciliar	1 farmacêutico por turno de atendimento
Atividades clínicas (Paciente internado em unidades de baixa e média complexidade) Atividades clínicas (Pacientes internados em unidades de alta complexidade)	1 farmacêutico para cada unidade clínica com até 40 leitos 1 farmacêutico por unidade clínica (máximo de 30 leitos)
Produção de kits para procedimentos	1 auxiliar por turno de produção, sob supervisão do farmacêutico
Farmácia em Centro cirúrgico	1 farmacêutico por turno 1 auxiliar de Farmácia para cada 4 salas de cirurgia em funcionamento, por turno
Farmacovigilância	1 farmacêutico exclusivo
Informação sobre medicamentos	1 farmacêutico exclusivo
Pesquisa Clínica (Ensaio Clínicos)	1 farmacêutico exclusivo

Fonte: SBRAFH, 2017

Muitas tentativas dos Conselhos de Farmácia para estabelecer um número mínimo de profissionais foram frustradas. Não se sabe ao certo do porquê isso ocorreu, mas algumas hipóteses podem ser pensadas:

- Desvalorização dos serviços farmacêuticos;
- Alto de cada funcionário;
- As gerências não veem necessidade, porque “sempre foi assim e sempre deu certo”.

O fato é que o aconselhamento do número mínimo estabelecido pela SBRAFH levou em conta todos esses itens trazendo para uma realidade mais próxima daquela que vivemos.

Também, devemos lembrar que com o aumento da complexidade do atendimento e do número de pessoas atendidas o número sugerido pode ser alterado para que a execução das tarefas ocorra adequadamente. Sobre o assunto, a SBRAFH coloca:

“Ressaltamos que a composição do quadro de funcionários das Farmácias Hospitalares e dos demais Serviços de Saúde deverão se basear nos Parâmetros Mínimos para Recursos Humanos considerando o porte, as atividades desempenhadas e a complexidade de cada estabelecimento.”
(SBRAFH, 2017)

Os estabelecimentos de atenção à saúde devem ter compromisso com seus usuários de modo a atingir as metas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, conforme as seguintes prioridades:

- Segurança do Paciente;
- Qualidade da assistência;
- Efetividade da terapia medicamentosa;
- Uso racional de medicamentos e produtos para saúde;
- Controle de Infecção;
- Cumprimento da Legislação Sanitária vigente.

E então? Consegui gravar tudinho? Vamos relemburar. Primeiro conhecemos quais eram os requisitos básicos de uma farmácia em estabelecimento de saúde conforme a RDC 50/2002 da ANVISA. Em seguida vimos quais os equipamentos mínimos e recursos humanos estabelecidos pela SBRAFH e ANVISA. Apesar de não ter poder de lei, as publicações da SBRAFH são bastante esclarecedoras e práticas, tornando-se de grande valia no dia-a-dia do profissional.

Explorando os princípios da administração

INTRODUÇÃO:

As atividades de gestão fazem parte do dia-a-dia de qualquer profissional, cabe a ele reconhecer. Muitas vezes a nossa formação técnica não nos permite enxergar e nos distancia, às vezes, até nos causa aversão para compreender as atividades, meios, métodos e ferramentas de gestão para que possamos utilizar ao nosso favor. Nessa competência iremos abordar as atividades administrativas de um gestor de serviços de farmácia com foco na gestão de custos e de estoque. Para isso precisamos tomar o conceito de economia para fundamentar a nossa compreensão: é a ciência humana que estuda como a sociedade administra seus recursos escassos em um ambiente onde as necessidades são ilimitadas.



Para você entender um pouco mais a importância disso, vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você trabalha em uma diretoria técnica de uma empresa público-privada que faz a gestão de hospitais públicos estaduais e uma das suas responsabilidades como gestor de serviços farmacêuticos é realizar o controle dos pedidos de compra de medicamento. Esses hospitais adotam como medicamentos padronizados aqueles pertencentes às listas nacional e estadual.

Em determinada situação um dos hospitais requisita um medicamento não padrão que diz ser essencial, mas nenhum outro hospital que presta o mesmo serviço o utiliza. Esse medicamento além de não ser pago pelo SUS, apresenta seu valor de dose unitária de cerca de 4 dígitos. Tendo em vista os fatos apresentados, você compraria ou não o medicamento? Será realmente essencial, já que os outros hospitais não utilizam?

Voltando a nossa premissa.... os recursos são escassos – nesse caso é o próprio orçamento... o medicamento não será pago pelo repasse do SUS, então caberá a quem pagar o fornecedor? As necessidades são ilimitadas – dentre outros motivos, o marketing farmacêutico influencia fortemente os prescritores na escolha dos medicamentos e, muitas vezes, escolhem medicamentos não padrão e/ou não avaliados pela CONITEC. Outros motivos envolvem o conhecimento médico empírico que mostra que determinado medicamento apresenta melhores resultados que outros e a própria disponibilidade no hospital ou no mercado.

O administrador deve interpretar os objetivos e necessidades da empresa que trabalha, no nosso caso o hospital e transformá-la em ação por meio de planejamento, organização, direção e controle (ciclo PDCA)

Assim, podemos entender o quanto precisamos compreender a fundo de que modo podemos ofertar os medicamentos com melhores resultados e com menores custo. Como pode-se controlar o estoque e realizar o pedido no momento correto para que não haja falta e nem excesso.

Histórico dos princípios da administração

Ao longo do tempo as abordagens da administração mutaram para se enquadrarem às suas realidades temporais. O início se deu nas fábricas onde os engenheiros, a fim de aumentar a qualidade dos

produtos e a eficiência do processo, realizaram a racionalização e descrição dos procedimentos realizados.

A primeira abordagem administrativa é a com ênfase em tarefas. Essa surgiu na escola de administração científica no início do século XX e foi descrita por Frederick Taylor. Essa teoria visava aumentar a eficiência, isso quer dizer melhorar o modo de realizar tarefas e diminuir o desperdício, seja material, humano ou temporal.

A partir do estudo do tempo de execução das tarefas e o modo como as tarefas eram executadas, Taylor bolou uma forma incomum de pagamento na época que consistia no pagamento por produtividade. O sistema denominado de *piece-rate system* determinava o quanto o trabalhador deveria produzir em um determinado tempo e assim era determinado o seu salário.

Em 1911, Taylor estabeleceu os objetivos da administração científica:

- Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, para substituir o velho método empírico.
- Selecionar cientificamente e depois treinar, instruir e desenvolver o trabalhador, que, no passado, escolhia seu próprio trabalho e treinava-se o melhor que podia.
- Cooperar sinceramente com os trabalhadores, de modo a garantir que o trabalho seja feito de acordo com princípios da ciência que foi desenvolvida.
- Reconhecer que existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade entre a administração e os trabalhadores. A administração incumbe-se de todo o trabalho para o qual esteja mais bem preparada que os trabalhadores, enquanto no passado quase todo o trabalho e a maior parte da responsabilidade recaíam sobre a mão de obra.

Para que esses objetivos fossem alcançados Taylor estabeleceu algumas ferramentas. Devemos lembrar que se tratava do início do século XX e a tecnologia daquela época não é a mesma de hoje. São eles: estudos de tempos e movimentos; padronização de ferramentas e instrumentos; padronização de movimentos; conveniência de uma área de planejamento; cartões de instruções; sistema de pagamento de acordo com o desempenho; e, cálculo de custos.



VOCÊ SABIA?

"Entre 1874 e 1878, Taylor trabalhou para uma empresa fabricante de bombas hidráulicas, onde aprendeu o ofício de torneiro. Foi também nessa empresa que começou a observar o que considerava má administração, "corpo mole" dos funcionários e relações de má qualidade entre os trabalhadores e os gerentes. Em 1878, ingressou na Midvale Steel, uma usina siderúrgica, na qual passou 12 anos, começando como trabalhador e terminando como engenheiro-chefe. Nesse período, retomou seus estudos, desta vez em engenharia. (...) Também começou a desenvolver os primeiros de uma série de muitos aprimoramentos técnicos. (...) Nessa empresa Taylor inventou, com J. Maunsel White, o que se tornou conhecido como o processo Taylor-White para o tratamento térmico do aço empregado na produção de ferramentas. Essa invenção trouxe aprimoramentos de 200% a 300% na capacidade de corte." (Maximiano, 2018).

Em 1916, o casal Gilbreth publicaram *Fatigue study* (Estudo da fadiga), pesquisa que dividia a fadiga – cansaço físico ou mental gerado pelo trabalho – em duas categorias: necessária (resultante da atividade que precisa ser feita para completar uma tarefa) e desnecessária (resultante de atividade que não precisaria ter sido feita). Para minimizar a fadiga, o casal afirmava que o caminho é o estudo científico dos movimentos e a introdução de aprimoramentos nos métodos de trabalho.

A fadiga desnecessária seria reduzida se o ambiente de trabalho fosse redesenhado, e a fadiga necessária seria minimizada por meio de técnicas mais eficientes e de períodos de descanso. Além disso, propuseram a redução das horas diárias de trabalho e a implantação ou o aumento de dias de descanso remunerado.

A gestão por processos, elaborada no século XXI, tem como base reconhecer as atividades que agregam valor e as que não agregam valor. As atividades que não agregam valor podem, por sua vez, ser dividida em não necessária e necessária. As atividades que agregam valor são aquelas que são necessárias para o produto ou serviço e que fazem parte da essência ou daquilo que o cliente enxerga como essencial para

aquele produto ou serviço; por exemplo: detalhes para enfeitar o prato ou o design de um produto. As atividades que não agregam valor, mas que são necessárias, são, por exemplo, movimentos realizados durante a execução de um serviço ou na produção de um produto que o cliente não enxerga e que para ele não faz diferença; contudo, sem o determinado movimento a matéria prima não seria levada para a sala de produção. Por sua vez, os que não são necessárias são aquelas atividades que não deveriam existir dentro de um processo e que causam desperdício. Por exemplo: excesso de movimentos. Agora... considerando isso.... qual seria a diferença da teoria da gestão por processos para a teoria descrita pelo casal Gilbreth?

Ao mesmo tempo em que a Escola de Administração Científica e as teorias de Taylor eram investigadas e implementadas, Henry Ford desenvolveu e implementou a produção em série, por meio de uma linha de montagem móvel. Interessantemente e para a surpresa de Taylor, Ford havia implementado as ideias que ele havia tido, mas, ainda, nem o conhecia.

Henry Ford padronizou as peças e componentes de seus produtos e especializou cada trabalhador para uma atividade. A primeira providência tomada por Ford foi diminuir o tempo que os trabalhadores tinham em ir buscar peças ou ferramentas e retornar à sua estação de trabalho. Assim, responsabilizando pessoas específicas para esses fins. Além disso, diminuiu o tempo de trabalho para oito horas diárias e duplicou os salários. Não se engane em pensar que ele estava sendo bonzinho com os trabalhadores, Ford percebeu que quando trabalhava-se muito tempo a chance de erros aumentavam e o aumento do salário foi uma estratégia que Ford utilizou para que seus trabalhadores pudessem comprar os automóveis que estavam construindo.

Sobre o modelo de Ford é muito importante reforçar que a pessoa especializada em uma atividade não tinha perspectiva de crescimento ou de mudança de atividade, outras posições administrativas também surgiram durante o período como a do supervisor e valorização do engenheiro responsável pela produção.

Henry Fayol foi o primeiro um engenheiro francês que sistematizou a pesquisa e o ensino da administração. Além do mais, a administração para assegurar o cumprimento de sua responsabilidade fundamental,

que é a condução do empreendimento, o executivo principal conta com seis funções interdependentes: técnica, comercial, financeira, segurança, contabilidade, administração. Por sua vez, a administração apresenta cinco funções, as quais são descritas por Fayol como (Maximiano, 2018):

a. Técnica (produção, manufatura). "A função técnica nem sempre é a mais importante de todas. Mesmo nas empresas industriais, há circunstâncias em que qualquer uma das outras funções pode ter uma influência muito maior no desenvolvimento da empresa do que a função técnica."

b. Comercial (compra, venda, troca). "A prosperidade de uma empresa industrial depende tanto da função comercial quanto da função técnica; se o produto não se vende, temos a ruína."

c. Financeira (procura e utilização de capital). "Constitui condição essencial de êxito ter constantemente à vista a situação financeira da empresa."

d. Segurança (proteção da propriedade e das pessoas). "Sua missão é proteger os bens e as pessoas contra o roubo, o incêndio e a inundação, e evitar as greves, os atentados e, em geral, todos os obstáculos de ordem que possam comprometer o progresso e mesmo a vida da empresa."

e. Contabilidade (registro de estoques, balanços, custos, estatísticas). "Constitui o órgão de visão das empresas. Deve revelar, a qualquer momento, a posição e o rumo do negócio. Deve dar informações exatas, claras e precisas sobre a situação econômica da empresa."

f. Administração (previsão [em francês, *prevoyance* – literalmente, previdência], organização, comando, coordenação e controle). "Nenhuma das cinco funções precedentes tem o encargo de formular o programa geral de ação da empresa, de constituir o seu corpo social, de coordenar os esforços, de harmonizar os atos. Essas operações... constituem outra função, designada habitualmente sob o nome de administração, cujas atribuições e esfera de ação são muito mal definidas."

Além das cinco funções Fayol estabeleceu 14 princípios que até hoje são empregados na administração:

a. Divisão do trabalho: promove a produção mais eficiente e com menor esforço;

- b. Autoridade: institucional e pessoal, acompanhada das responsabilidades correspondentes;
- c. Disciplina: para Fayol o sinônimo de disciplina é a obediência, assiduidade, atividade, postura e sinais de respeito de acordo com o estabelecido pela empresa e costumes;
- d. Unidade de comando: isso quer dizer que em uma hierarquia, um funcionário deverá apresentar uma única unidade de comando ou chefia para que não haja duplicidade de comandos ou comandos contrários entre si.
- e. Unidade de direção: a segmentação de uma indústria em direções se deve ao fato de que as tarefas devem ser subdivididas para que não haja atividades realizadas em duplicidade e convergência de esforços.
- f. Subordinação do interesse individual ao interesse geral, conciliando os interesses contraditórios quando necessário. Os meios para realizar esse objetivo são: firmeza e bons exemplos mostrados pelos superiores, a maior equidade possível nos acordos entre a empresa e seus empregados, a supervisão constante do funcionamento da empresa pelo dirigente.
- g. Remuneração equitativa do esforço
- h. Grau de centralização e descentralização, escolha feita em função das condições de atividade e de qualidade do pessoal.
- i. Cadeia hierárquica (ou princípio da administração hierárquica): Este caminho "é imposto simultaneamente pela necessidade de garantir a transmissão de informações e pela unidade de comando
- j. Ordem material e social: cada coisa em seu lugar.
- k. Equidade no tratamento dos empregados, ou seja, mesmo tratamento para os diretores e os estagiários, responsáveis pela limpeza ou analistas.
- l. Estabilidade pessoal: as pessoas que trabalham em empresas saudáveis são mais estáveis do que aqueles que trabalham em lugares com problemas;
- m. Iniciativa: Segundo Fayol "Conceber um plano e assegurar seu sucesso é uma das grandes satisfações do homem inteligente; é também um dos mais poderosos estimulantes da atividade humana [...]. A iniciativa de todos, ajuntando-se à do chefe e, se necessário, suplementando-a, é grande

força para as empresas... é preciso que o chefe saiba sacrificar o amor próprio para dar tais satisfações a seus subordinados." (Maximiano, 2018).

n. Senso de espírito de corpo ou união, que é essencial para a direção reforçar a moral dos trabalhadores e de suas capacidades. "É preciso talento real para coordenar os esforços, estimular o zelo, utilizar as faculdades de todos e recompensar o mérito de cada um sem despertar ciúmes e sem perturbar a harmonia das relações."

Max Weber, sua vez, foi um pesquisador alemão que também apresentou uma teoria administrativa com ênfase nas organizações. Para ele: "o principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos de pessoas.". Além disso, para ele qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia. A organização burocrata ou formal apresenta algumas características:

- Formalidade significa que as organizações são constituídas com base em normas e regulamentos explícitos, ou leis, que estipulam os direitos e deveres dos participantes;

- Impessoalidade significa que, numa burocracia, nenhuma pessoa é empregada ou vassalo de outra. As relações entre as pessoas que integram as organizações burocráticas são governadas pelos cargos que elas ocupam e pelos direitos e deveres investidos nesses cargos;

- Profissionalismo significa que, de forma geral, os cargos de uma burocracia oferecem a seus ocupantes carreira profissional e meios de vida, além de formação. O integrante de uma burocracia é um funcionário que faz do cargo um meio de vida, recebendo um salário regular em troca de seus serviços (Maximiano, 2018).

Outras características como divisão formal do trabalho, hierarquia, competência técnica, separação entre a propriedade e a administração e a profissionalização dos funcionários.

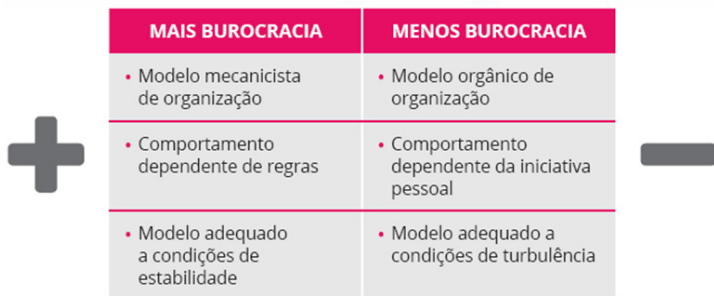
Infelizmente, Weber não contou com o poder do ser humano de dificultar e distorcer as coisas.... ao longo do tempo, foram identificadas, por outros pesquisadores, disfunções: patrimonialismo, excesso de regras, hierarquia, mecanicismo, individualismo, resistência às mudanças, dificuldades para os usuários. Ainda, mecanicismo, individualismo, interrupção do fluxo das informações, desestímulo à inovação e indefinição de responsabilidade.

Em meados do século XX, a pesquisa sobre as organizações permitiu a identificação de modelos alternativos ao tipo ideal weberiano. Esses modelos retratam organizações cujo funcionamento depende mais das pessoas do que das regras, sendo assim o "oposto" ao idealismo de Weber. Esse pensamento recebe designações como modelo pós-burocrático, modelo orgânico e Sistema 4. Algumas definições dos tipos organizacionais provenientes do modelo pós-burocrático são o tipo mecanicista e o orgânico.

O tipo mecanicista ou mecanístico de organização aplica-se a organizações altamente regulamentadas é adequado a condições ambientais relativamente estáveis. Essas organizações são as "quadradas" e tradicionais. Por sua vez, o tipo orgânico (ou organísmico, *organismic*) descreve as organizações que se assemelham ou que procuram assemelhar-se aos organismos vivos se adaptando a cada. Ambientes assim oferecem problemas complexos que não podem ser resolvidos por pessoas com especialidades tradicionais. Por isso, nos sistemas orgânicos, há contínua redefinição de tarefas e a hierarquia linear muitas vezes é substituída pela em rede ou circular.

Esses modelos formam com o tipo ideal weberiano uma "régua" bipolar, que possibilita avaliar o grau de burocratização das organizações. Essa ideia de modelo que depende do ambiente é chamada enfoque contingencial ou situacional da organização.

Figura 2. Os dois extremos da régua do ideal weberiano



MAIS BUROCRACIA	MENOS BUROCRACIA
Modelo mecanicista de organização	Modelo orgânico de organização
Comportamento dependente de regras	Comportamento dependente da iniciativa pessoal
Modelo adequado a condições de estabilidade	Modelo adequado a condições de turbulência

Fonte: Maximiano, 2018

Com a evolução do pensamento das pessoas, essas definições também se alteraram. Promoveu-se as organizações com ênfase às pessoas. Os precursores dessa linha foram Elton Mayo (1880-1949) e

Kurt Lewin (1890-1947), fundadores da Escola das Relações Humanas. Trata-se da abordagem mais democrática e liberalizante ocorrida na teoria da administração.

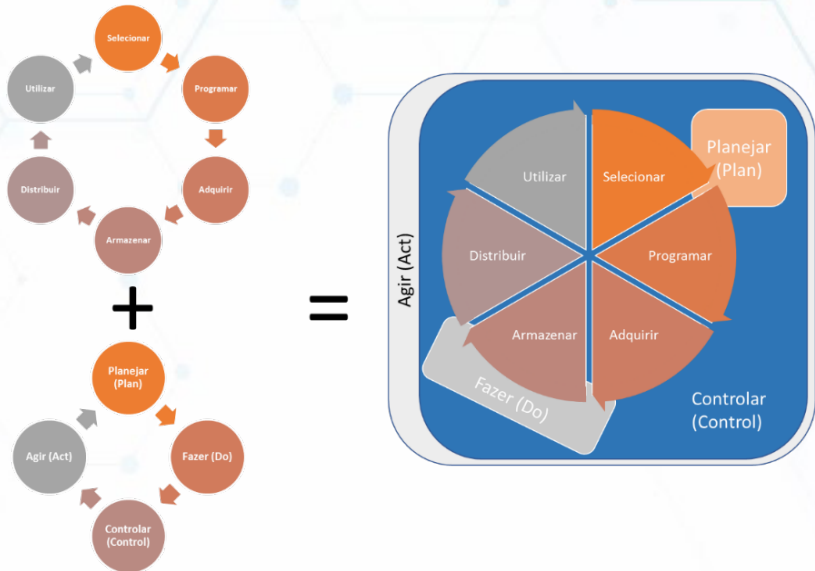
O movimento humanístico, com o objetivo de dar maior espontaneidade aos trabalhadores, substituiu os conceitos de organização formal, autoridade e responsabilidade, hierarquia, unidade de comando, estudos de tempos e movimentos, eficiência, organização em departamentos, princípios gerais da administração etc. Apresenta conceitos como organização informal, motivação e necessidades humanas básicas, dinâmica de grupo, comunicação e liderança, se afastando do proposto por Taylor e Fayol.

A segunda abordagem humanista, a Escola do Comportamento Organizacional, surgiu em 1947, que valoriza a decisão (Teoria das Decisões) como elemento muito mais importante que a execução que a sucede. A terceira abordagem humanista denomina-se Desenvolvimento Organizacional (DO) e é voltada para estratégias de mudança organizacional, planejada por modelos de diagnóstico, intervenção e mudanças, que envolvem modificações estruturais e comportamentais para aumentar a eficiência e a eficácia das empresas. Mais tarde incorporou-se a análise do ambiente externo, além das variáveis endógenas.

Mas... e hoje em dia? Hoje em dia, na prática, as organizações apresentam características de uma ou outra linha, ou ainda, de todas elas em departamentos ou diretorias diferentes. Em um mundo perfeito, as organizações seriam baseadas nas melhores qualidades das diferentes teorias para uma gestão completa... das falhas devemos ver como oportunidades de melhorias.

É importante lembrar que esses conceitos não serão aplicados em uma ou outra etapa do ciclo da assistência farmacêutica (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização), mas, sim, em todas essas etapas. Além disso, também devemos ter em mente o comparativo do bom e velho ciclo PDCA e o ciclo da assistência farmacêutica.

Figura 3. Comparação entre o ciclo da assistência farmacêutica e o ciclo PDCA



Fonte: o autor, 2019

Então? Aprendeu tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu a competência desse capítulo vamos dar uma breve revisada. As teorias da administração surgiram com o Taylorismo e a aplicação do método científico na administração, racionalizando o sistema produtivo por meio de estudos de tempos e movimentos. Apresentava 5 princípios: planejar, preparar, executar, estabelecer cargos e funções e padronização. Por meio dessas ideias, Henry Ford também padronizou suas indústrias. Weber acreditava que só com a impessoalidade e formalidade poderia estabelecer autoridade sobre os funcionários. Para Weber a organização deve ser uma burocracia com, minimamente, formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Fayol tendo em sua frente a figura do que acreditava ser o homo economicus (que é só estimulado pelo dinheiro) elencou 14 princípios que para ele eram fundamentais. Foram eles: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, disciplina, remuneração, interesses gerais, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Em contraposição,

surgiu a Escola humanística que passou a ver o homo social. Ela possui três características principais, que são: o ser humano não possui comportamento mecânico, o homem é guiado pelo sistema social e possui necessidades (segurança, afeto, aprovação etc.). Em seguida, o conceito de homem organizacional surgiu e abrange mais características sociais e necessidades sociais e psicológicas. Hoje, a visão é holística, adequando a cada ambiente as características necessárias.

Gestão e a Política Nacional de Medicamentos e da Assistência Farmacêutica

INTRODUÇÃO:



Nessa competência vamos explorar a relação entre a gestão dos serviços de farmácia e as Políticas Nacionais de Medicamento e da Assistência Farmacêutica. Isso se deve ao alto custo que os medicamentos representam no montante final dos custos de um hospital, há a necessidade da racionalização de seu uso. Por meio de estratégias para a tomada de decisão, tem-se como objetivo final a racionalização dos gastos e do uso dos medicamentos para garantir ao usuário a melhor terapêutica ao menor custo.

Política Nacional de Medicamentos e OMS

A partir da premissa de racionalizar o uso dos medicamentos, a OMS (Organização Mundial da Saúde) estimula os seus países membros a terem uma política direcionada a medicamentos. Por meio dela, deve-se praticar ações que contemplem desde a descrição dos medicamentos até a utilização. Além de ser necessário estabelecer uma padronização dos medicamentos. Padronizar significa selecionar medicamentos que atendam as demandas epidemiológicas e que apresentam uma boa relação de custo benefício.

Essa padronização hoje ocorre nos níveis de governo federal, estadual e municipal, sendo tomadas como base pelos hospitais públicos

para estabelecer a sua própria padronização. Os estabelecimentos privados, por sua vez, estabelecem as suas padronizações de acordo com a necessidade.

Essa política, no Brasil, estabeleceu-se pela portaria 3916, de 30 de outubro de 1998, e é denominada de Política Nacional de Medicamentos. A PNM visa garantir a segurança, a eficácia e a qualidade do medicamento, além de promover o uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.

As principais diretrizes da PNM são: estabelecer a relação dos medicamentos essenciais (RENAME), reorientar a assistência farmacêutica, estimular a produção de medicamentos genéricos e a regulamentação sanitária de medicamentos. A PNM também tem como metas: promoção do uso racional de medicamentos, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico, promoção da produção de medicamentos e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.

Destas diretrizes, são consideradas prioridades: a revisão permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), a reorientação da Assistência Farmacêutica, a promoção do uso racional de medicamentos e a organização das atividades de Vigilância Sanitária de medicamentos.

RENAME

A RENAME é uma lista composta por medicamentos essenciais selecionados que são indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Também, serve como referência para o direcionamento da produção farmacêutica; para o desenvolvimento científico e tecnológico; e, para a política de medicamentos nos âmbitos estadual e municipal. As esferas de governo estadual e municipal devem padronizar seus medicamentos de modo a selecionar medicamentos que melhor atendam as doenças prevalentes na região.

A RENAME deve ser revisada periodicamente, já que a prevalência das enfermidades pode se alterar. Além disso, a tecnologia em saúde pode evoluir apresentando novas alternativas que sejam economicamente mais viáveis.

Regulamentação sanitária

As ações de vigilância sanitária são descentralizadas e a responsabilidade executiva é função dos estados e municípios. Apenas as funções de registro de medicamentos e as autorizações de funcionamento de empresas são competências do órgão central.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é responsável pelo registro dos medicamentos e por autorizar o funcionamento de todos os estabelecimentos com atividades farmacêuticas, tais como: produtores de medicamentos, distribuidoras, transportadoras, farmácias, incluindo as hospitalares, e drogarias.

A ANVISA, também, coordena e monitora o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nas questões relacionadas aos medicamentos, em conjunto as vigilâncias estaduais e municipais. Essa monitorização é denominada de farmacovigilância que é definida pela OMS como a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos.

Os objetivos da farmacovigilância são:

- velar pelo cuidado e pela segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas
- melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos
- detectar problemas relacionados com o uso de medicamentos e comunicar quaisquer achados de maneira oportuna;
- contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, permitindo a prevenção de danos e maximizando os benefícios
- fomentar o uso seguro, racional e mais eficaz de medicamentos (inclusive no tocante à efetividade em função do custo);
- promover compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua efetiva divulgação ao público.

Segundo a Organização Pan Americana de Saúde, a boa gestão da farmacovigilância é um escudo que protege os usuários de novas reações adversas e interações medicamentosas. Além disso, promove a reflexão acerca da melhor relação risco-benefício, promovendo um uso terapêutico

mais seguro e efetivo. Além dos medicamentos, outros produtos para a saúde também são acompanhados pela farmacovigilância, como os hemoderivados, as vacinas e os dispositivos médicos.

No Brasil, as notificações de vigilância podem ser feitas de maneira passiva ou ativa. A notificação passiva é feita por meio das notificações espontâneas, isto significa que o sistema aguarda a notificação do evento. Já, a notificação ativa ocorre quando o sistema parte em busca dos dados e é feita, normalmente, no ambiente hospitalar, ou seja, os profissionais observam as reações dos pacientes aos medicamentos em busca da ocorrência de eventos a serem reportados. É importante saber que a notificação deve ser feita mesmo que não haja uma conexão clara entre o sintoma e a medicação.

Esse sistema alimentado auxilia a identificar, caracterizar, prevenir ou minimizar os riscos relacionados a medicamentos.

Reorientação da assistência farmacêutica

A reorientação da Assistência Farmacêutica está fundamentada na descentralização da gestão, na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e eficácia do sistema de distribuição no setor público e no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos. Na PNM, a assistência farmacêutica é definida como:

"Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos."

Mais tarde, para a continuidade da reorientação da assistência farmacêutica, o Conselho Nacional de Saúde, em 2004, aprovou a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, por meio da Resolução n. 338. A PNAF é definida como: "Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população" (Brasil, 2004).

A qualificação do gerenciamento da Assistência Farmacêutica é possível por meio do planejamento, da organização e da estruturação das atividades desenvolvidas, visando aperfeiçoar os serviços ofertados à população. É importante lembrar que gerenciar é alcançar resultado utilizando eficientemente os recursos limitados, como fruto do conhecimento, habilidades e atitudes do gestor. Abrange ações de planejamento, de execução, de acompanhamento e de avaliação permanente dos resultados para realização de ações corretivas.

Olá! Estudou tudo? E aprendeu tudo mesmo? Nessa competência relacionamos assuntos de gestão com as Políticas Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica. Exploramos essas duas políticas e as consequências das suas implantações: RENAME, Reorientação da assistência farmacêutica, regulamentação sanitária, entre outras. E, aí? Belezinha? Não se esqueça: "Os milagres acontecem às vezes, mas é preciso trabalhar tremendamente para que aconteçam" – Peter Drucker (pai da administração moderna).

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização Brasília: Ministério da Saúde, 2 ed., 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. Disponível em: <http://bit.ly/390Bckk>

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 20 anos do SUS. Legislação. Disponível em: <http://bit.ly/2Shd86v>

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Resolução 338, de 06 de maio de 2004. Disponível em: <http://bit.ly/2Z8VogO>

CARVALHO, F. D. et al. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. São Paulo: Manole, 2014.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. São Paulo: Manole, 2 ed., 2010.

CHIAVENATO, I. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. São Paulo: Manole, 9 ed., 2009.

DANTAS, S. C. C. Farmácia e Controle das Infecções Hospitalares. Pharmacia Brasileira, n 80, fev./mar., 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Sa3G54>

JULIANI, R. G. M. Organização e funcionamento de farmácia hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.

MÁLAGÓN-LONDOÑO, G. et al. Gestão Hospitalar para uma administração eficaz. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 4 ed., 2019.

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas, 8 ed., 2018.

SIMONETTI, V.M.M.; et al. Gestão de suprimentos da farmácia hospitalar com a implantação de métodos gerenciais de insumos utilizados na manufatura. Revista Eletrônica Produção Engenharia v.2 n.1 p. 57 68. Jan.-Jul, 2009.

SALU, E. J. Administração Hospitalar no Brasil. São Paulo: Manole, 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR (SBRAFH). Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar. São Paulo: SBRAFH, 3 ed., 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2EIJTl2>

